

CAPÍTULO 1.9

Fibrilación Auricular Crónica

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

La **Fibrilación Auricular (FA)** es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica. Su manejo es un pilar fundamental de la cardiología, ya que impacta directamente en la calidad de vida del paciente y en la prevención de complicaciones graves como el **Accidente Cerebrovascular (ACV)** embólico.

Clasificación de la Fibrilación Auricular

Para definir la conducta terapéutica, es esencial clasificar la FA según su duración y la capacidad de revertir a ritmo sinusal:

TABLA 1.9.1: TIPO DE FA VS DEFINICIÓN

TIPO DE FA	DEFINICIÓN
Paroxística	Los episodios terminan de manera espontánea o con intervención en menos de 7 días (habitualmente < 48 horas).
Persistente	El episodio dura más de 7 días. Requiere intervención farmacológica o eléctrica para volver a ritmo sinusal.
Permanente	Se ha decidido no intentar más el control del ritmo (o los intentos han fallado). El paciente permanece en FA de forma crónica.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la FA implica una desorganización de la actividad eléctrica auricular, lo que lleva a una pérdida de la contracción efectiva de las aurículas. Esto favorece el estasis sanguíneo, especialmente en la orejuela izquierda, facilitando la formación de trombos.

Estrategias de Manejo: Control de Ritmo vs. Control de Frecuencia

Existen dos enfoques principales para el tratamiento de la FA crónica. La elección depende de la sintomatología, la edad y las comorbilidades del paciente.

1. Control de Frecuencia

El objetivo no es eliminar la arritmia, sino controlar la respuesta ventricular para evitar síntomas y la taquimiocardiopatía. - **Metas:** Frecuencia cardíaca (FC) en reposo generalmente entre 60 y 90 lpm (algunas guías permiten hasta < 110 lpm si el paciente está asintomático y la función ventricular es normal). - **Fármacos utilizados:** - **Betabloqueadores:** Como el **Atenolol**. En pacientes con **Insuficiencia Cardíaca** asociada, el **Carvedilol** es de elección por su beneficio demostrado en la mortalidad. - **Calcioantagonistas no dihidropiridínicos:** **Verapamilo** o **Diltiazem**. Son seguros y efectivos para el control de frecuencia. - **Digitales:** La **Digoxina** se utiliza habitualmente como segunda línea o cuando los anteriores están contraindicados o son insuficientes.

2. Control de Ritmo

El objetivo es restaurar y mantener el **ritmo sinusal**. - **Beneficios:** Mejora la capacidad funcional, la tolerancia al ejercicio y reduce los síntomas en pacientes que se sienten limitados a pesar de un buen control de frecuencia. - **Fármacos utilizados:** - **Amiodarona:** Es el fármaco más potente para mantener el ritmo sinusal, útil incluso en corazones con cardiopatía estructural. - **Propafenona:** Se puede utilizar en pacientes con "corazón sano" (sin cardiopatía isquémica ni estructural significativa).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Muchos pacientes creen estar asintomáticos con control de frecuencia, pero al recuperar el ritmo sinusal, refieren una notable mejoría en su estado físico y energía diaria. Siempre se debe considerar el control de ritmo en la FA paroxística y persistente.

Prevención de Tromboembolismo: La Anticoagulación

EUNACOM CRITERIOS

La decisión de anticoagular **NO** depende del tipo de FA (paroxística, persistente o permanente) ni de la estrategia elegida (ritmo o frecuencia). Depende exclusivamente del riesgo embólico del paciente.

Para evaluar este riesgo, utilizamos el score **CHA2DS2-VASc**:

TABLA 1.9.2: LETRA VS FACTOR DE RIESGO

LETRA	FACTOR DE RIESGO	PUNTOS
C	Cardiopatía (Insuficiencia cardíaca o disfunción VI)	1
H	Hipertensión Arterial	1
A2	Edad (Age) ≥ 75 años	2
D	Diabetes Mellitus	1
S2	Stroke (ACV), TIA o embolia sistémica previa	2
V	Enfermedad Vascular (IAM previo, EAP, placa aórtica)	1
A	Edad (Age) entre 65 y 74 años	1
Sc	Sexo femenino (Sex category)	1

¿A quién anticoagular según el puntaje?

Actualmente, el sexo femenino se considera un "modificador de riesgo" y no suma para la decisión inicial si es el único factor presente. 1. **0 puntos (hombres) o 1 punto (mujeres):** No requiere anticoagulación. 2. **2 o más puntos (hombres) o 3 o más puntos (mujeres):** Anticoagulación obligatoria. 3. **1 punto (hombres):** Se debe decidir caso a caso. La recomendación actual es anticoagular si el paciente tiene **65 años o más**. Si es menor de 65 años con otro factor, se puede individualizar.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Mito del riesgo de caídas: Es un error común no anticoagular a ancianos por miedo a que se caigan y hagan un hematoma subdural. El riesgo de un ACV embólico por FA en el adulto mayor es mucho más alto y devastador que el riesgo de hemorragia por trauma. ¡A los 80 años se anticoagulan de entrada!

Fármacos Anticoagulantes

- **Antagonistas de Vitamina K (Cumarínicos):** Como el Acenocumarol o la Warfarina. Requieren controles frecuentes de INR. - **Nuevos Anticoagulantes Orales (NACOs / DOACs):** Como Dabigatrán, Rivaroxabán o Apixabán. Son superiores en seguridad (menos riesgo de hemorragia intracraneal) y no requieren monitoreo de laboratorio, aunque su costo es mayor.

Excepciones Importantes

- **Estenosis Mitral:** Los pacientes con estenosis mitral moderada-severa y FA tienen un riesgo embólico altísimo. Deben anticoagularse **siempre**, independientemente del CHA2DS2-VASc, y se deben usar preferentemente **cumarínicos** (los NACOs no están aprobados en FA valvular reumática). - **Aspirina:** No previene

eficazmente el ACV en pacientes con FA. Solo se mantiene si el paciente tiene otra indicación clara (ej. enfermedad coronaria), evaluando siempre el riesgo de sangrado al combinarla con anticoagulantes.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente tiene "Cardiopatía Hipertensiva", ya suma 2 puntos automáticamente: 1 por la Hipertensión (H) y 1 por la Cardiopatía (C). Ese paciente debe ser anticoagulado.

Resumen de Manejo para EUNACOM

1. **Diagnóstico:** Electrocardiograma (ausencia de ondas P, intervalos R-R irregulares). 2. **Evaluar Estabilidad:** Si hay compromiso hemodinámico, cardioversión eléctrica de urgencia. 3. **Control de Frecuencia:** Betabloqueadores o Calcioantagonistas (Verapamilo/Diltiazem). 4. **Evaluar Anticoagulación:** Aplicar CHA₂DS₂-VASc. 5. **Definir Estrategia a largo plazo:** ¿Ritmo o Frecuencia? (Considerar edad, síntomas y tamaño de la aurícula izquierda).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 80 años con FA permanente de 5 años, asintomática con FC controlada en 85 lpm con Metoprolol. Ecocardiograma muestra AI dilatada (55 mm) y FEVI conservada."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

En FA permanente (aceptada), NO se intenta cardioversión ni control del ritmo. El objetivo es control de frecuencia (FC < 110 lpm en reposo) y anticoagulación crónica según CHA₂DS₂-VASc. La dilatación auricular marcada hace improbable mantener ritmo sinusal.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La FA permanente es una decisión médico-paciente de no intentar restaurar ritmo sinusal
- El control de frecuencia leniente con FC menor a 110 lpm es el objetivo en FA permanente
- Los antiarrítmicos no tienen rol en FA permanente ya que no se busca control de ritmo
- La anticoagulación depende del CHA₂DS₂-VASc, no del tipo de FA
- La aurícula izquierda dilatada mayor a 50 mm favorece la perpetuación de la FA
- La ablación del nodo AV con marcapasos es el último recurso en FA con frecuencia incontrolable
- Digoxina es útil como coadyuvante pero no como monoterapia para control de frecuencia

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIBRILACIÓN AURICULAR CRÓNICA)

PREGUNTA 1

Paciente de 82 años con FA permanente aceptada, FEVI 55%, asintomático. FC en reposo de 95 lpm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Aumentar dosis de betabloqueador para lograr FC menor a 80 lpm
- B)** Mantener tratamiento actual, FC adecuada según estrategia leniente
- C)** Iniciar amiodarona para intentar cardioversión
- D)** Realizar cardioversión eléctrica
- E)** Ablación del nodo AV con marcapasos

PREGUNTA 2

Paciente con FA permanente de 3 años de evolución. Ecocardiograma muestra aurícula izquierda de 55 mm. CHA₂DS₂-VASc de 1 en hombre. ¿Qué conducta toma respecto a anticoagulación?

- A)** No anticoagular porque la FA es permanente y estable
- B)** Aspirina como alternativa
- C)** Considerar anticoagulación según riesgo individual
- D)** Anticoagulación obligatoria
- E)** Solo anticoagular si tiene episodios paroxísticos

PREGUNTA 3

Paciente con FA permanente, en tratamiento con metoprolol 200 mg al día y digoxina. FC en reposo de 130 lpm persistente. ¿Cuál es el siguiente paso?

- A)** Agregar verapamilo al esquema
- B)** Cambiar a amiodarona
- C)** Considerar ablación del nodo AV con implante de marcapasos
- D)** Cardioversión eléctrica urgente
- E)** Suspender digoxina e iniciar diltiazem

RESUMEN: FIBRILACIÓN AURICULAR CRÓNICA

La fibrilación auricular crónica, también denominada permanente, se define como aquella en la que se ha aceptado la arritmia como ritmo definitivo del paciente, sin intentos de cardioversión. La decisión de aceptar la FA como permanente implica que los esfuerzos terapéuticos se centran exclusivamente en el control de frecuencia y la prevención tromboembólica. En la FA crónica, la aurícula izquierda suele estar dilatada y con remodelado eléctrico y estructural avanzado, lo que hace improbable mantener ritmo sinusal a largo plazo incluso con tratamiento. Los factores que favorecen la clasificación como permanente incluyen duración prolongada de la arritmia, aurícula izquierda mayor a 50 mm, edad avanzada, múltiples comorbilidades y fracasos previos de cardioversión. El manejo se centra en control de frecuencia con betabloqueadores, digoxina o su combinación, y anticoagulación según CHA₂DS₂-VASc. La estrategia de control de frecuencia leniente con objetivo de frecuencia menor a 110 latidos por minuto en reposo ha demostrado no ser inferior a la estrategia estricta. Los antiarrítmicos no tienen rol en la FA permanente ya que no se busca restaurar el ritmo sinusal.